

Radar de sinais relevantes para a realidade hospitalar nacional

**Portugal
08/2026**

Versão nº 1 de 15-09-2026

Relatório produzido pela PDH
para a produção de informação relevante na área da
farmacovigilância.

RESUMO

O período incluiu a suspensão imediata da comercialização, dispensa e administração do lote L25428A de Salofalk (messalazina 3000 mg granulado) determinada pelo INFARMED, com recomendação de não interromper abruptamente os tratamentos por iniciativa própria e de contactar o médico assistente [N14], a publicação da nova edição do Boletim de Farmacovigilância do INFARMED [N8], sinais de desproporcionalidade de doença de refluxo gastroesofágico com agonistas do recetor GLP-1 [P1] e sinais de segurança do aciclovir em neonatos [P10], além de contexto sobre deteção de sinais e automatização [N15][N22].

SINAL A — RECOLHA DO LOTE L25428A DE SALOFALK POR DESCONFORMIDADE NA SERIALIZAÇÃO

Tipo de desenvolvimento: recolha / desconformidade de serialização e rastreabilidade

Prioridade: Alta

Áreas funcionais afetadas: Gestão de stocks e circuitos do medicamento; Segurança do doente; Sistemas de informação; Formação de profissionais

O que aconteceu: O INFARMED, Autoridade Nacional do Medicamento, ordenou a retirada imediata do mercado de um lote de Salofalk, suspendendo a sua comercialização em todo o território nacional. A medida abrange distribuidores por grosso, farmácias comunitárias e serviços farmacêuticos hospitalares: as entidades que disponham de embalagens do lote não as podem vender, dispensar ou administrar, devendo proceder à sua devolução. A decisão foi divulgada por circular informativa em 1 de setembro. O Titular de Autorização de Introdução no Mercado, a empresa Dr. Falk Pharma Portugal, está a proceder à recolha voluntária das unidades em circulação. O INFARMED recomendou simultaneamente que os doentes não interrompam o tratamento abruptamente e contactem o médico assistente para avaliação de eventual substituição.

Contexto e motivo: A fonte descreve um desvio relacionado com a serialização, ligado ao sistema de conformidade e verificação digital utilizado para a rastreabilidade das embalagens. Não foram reportados, até ao momento, problemas de qualidade química ou contaminação da substância ativa. A fonte não especifica a natureza exata da anomalia nem se foi detetada suspeita de falsificação.

Medicamentos, produtos ou sistemas afetados: Salofalk (messalazina 3000 mg, granulado gastrorresistente de libertação prolongada), embalagem de 60 saquetas, registo n.º 5398433, lote L25428A, com prazo de validade até novembro de 2029.

Impacto potencial para farmácia hospitalar em Portugal: A medida abrange os serviços farmacêuticos hospitalares. As unidades do lote identificadas nos stocks hospitalares não devem ser vendidas, dispensadas ou administradas e devem ser devolvidas. Os doentes em tratamento não devem interromper a terapêutica por iniciativa própria; a eventual substituição deve ser avaliada pelo médico assistente.

Ação sugerida: Identificar o lote L25428A nos stocks sob responsabilidade dos serviços farmacêuticos, impedir a sua venda, dispensa e administração e proceder à devolução das unidades conforme as instruções aplicáveis. Comunicar às equipas clínicas e aos doentes em ambulatório que não devem interromper o tratamento sem avaliação médica.

Fonte(s): [N14]

Diário de Notícias (DN): [dn.pt](https://www.dn.pt)

SINAL B — DOENÇA DE REFLUXO GASTROESOFÁGICO ASSOCIADA A AGONISTAS DO RECETOR GLP-1

Tipo de desenvolvimento: sinal de segurança / artigo científico

Prioridade: Média

Áreas funcionais afetadas: Monitorização terapêutica; Notificação de RAM; Segurança do doente; Comissão de Farmácia e Terapêutica

O que aconteceu: Um estudo de desproporcionalidade multi-base analisou o FAERS, o JADER e o Canada Vigilance, comparando os agonistas do recetor GLP-1 (GLP-1 RAs) com inibidores da DPP-4 como comparadores ativos, e detetou sinais significativos de doença de refluxo gastroesofágico (GERD) em todas as bases: FAERS (ROR 2,83; IC 95% 2,39–3,35), JADER (ROR 4,76; IC 95% 2,45–9,27) e Canada Vigilance (ROR 2,91; IC 95% 1,97–4,31), num total de 260 417 relatos relativos a GLP-1 RAs. Os sinais mais fortes ocorreram com semaglutide (3,44–6,93), seguida de liraglutide, tirzepatide e dulaglutide; a exenatida apresentou associação inversa no FAERS (ROR 0,60). A força do sinal aumentou com a idade (idade igual ou superior a 65 anos: ROR 3,01; p de tendência = 0,028).

Contexto e motivo: Os eventos adversos gastrointestinais dos GLP-1 RAs são conhecidos, mas a associação específica com GERD não tinha sido avaliada de forma cruzada em populações diversas. O estudo procurou identificar sinais consistentes entre populações ocidentais e asiáticas.

Medicamentos afetados: semaglutide, liraglutide, tirzepatide, dulaglutide e exenatida (GLP-1 RAs).

Impacto potencial para farmácia hospitalar em Portugal: O estudo pode informar a monitorização de sintomas de refluxo durante a terapêutica com GLP-1 RAs, com atenção particular aos doentes com idade igual ou superior a 65 anos.

Ação sugerida: Monitorizar sintomas de refluxo durante a terapêutica com GLP-1 RAs, sobretudo em doentes idosos, e considerar este sinal na revisão farmacêutica e na discussão clínica dos casos relevantes.

Fonte(s): [P1]

PubMed: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42682267

SINAL C — SEGURANÇA DO ACICLOVIR EM NEONATOS: EVENTOS NÃO DESCRITOS NA INFORMAÇÃO DO MEDICAMENTO

Tipo de desenvolvimento: sinal de segurança / artigo científico

Prioridade: Média

Áreas funcionais afetadas: Segurança do doente; Monitorização terapêutica; Notificação de RAM; Investigação

O que aconteceu: Um estudo observacional retrospectivo no FAERS, abrangendo 2004 até ao terceiro trimestre de 2024, analisou notificações em neonatos com idade igual ou inferior a 28 dias nas quais o aciclovir era o principal medicamento suspeito. Foram aplicados quatro métodos de desproporcionalidade — ROR, PRR, BCPNN e EBGM — e foi exigida significância nos quatro métodos para considerar um sinal positivo. Foram identificadas 130 notificações com 409 eventos adversos, com sinais positivos em quatro classes de sistemas de órgãos: afeções cutâneas e do tecido subcutâneo (ROR 6,22), afeções gerais e no local de administração (ROR 4,27), afeções hepatobiliares (ROR 3,85) e afeções renais e urinárias (ROR 3,84). Ao nível dos termos preferenciais, destacaram-se necrose/edema no local de perfusão (ROR 939,92), artrite (ROR 179,47), exfoliação/necrose cutânea (ROR 131,18) e doença de Kawasaki (ROR 114,20). Doença de Kawasaki, hemorragia retal e colite necrosante não estavam descritas na informação do medicamento.

Contexto e motivo: O aciclovir é o tratamento de primeira linha da infeção neonatal por vírus herpes simplex, mas a evidência de segurança nesta população permanece limitada. O estudo recorreu a dados de farmacovigilância do mundo real para caracterizar o perfil de segurança.

Medicamentos afetados: aciclovir em neonatos.

Impacto potencial para farmácia hospitalar em Portugal: O achado de necrose/edema no local de perfusão é relevante para a vigilância clínica durante a administração. Os autores sublinham a necessidade de monitorização clínica cuidadosa perante sinais cutâneos, hepatobiliares, renais, gastrointestinais ou imunes, especialmente em serviços de Neonatologia e unidades de cuidados intensivos neonatais.

Ação sugerida: Reforçar a monitorização clínica cuidadosa dos neonatos tratados com aciclovir, incluindo a vigilância do local de perfusão e a atenção a eventos cutâneos, hepatobiliares, renais, gastrointestinais ou imunes. Considerar especificamente os eventos identificados como não descritos na informação do medicamento — doença de Kawasaki, hemorragia retal e colite necrosante — na avaliação farmacovigilância dos casos.

Fonte(s): [P10]

PubMed: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42675701

OUTRAS NOVIDADES RELEVANTES

Farmacovigilância Regulamentar

Nova Edição do Boletim de Farmacovigilância do INFARMED (Volume 30, n.º 5 e 6, maio e junho de 2026). O INFARMED disponibilizou, a 7 de agosto de 2026, a nova edição do Boletim de Farmacovigilância, consultável na área de Publicações do organismo.

Relevância para a farmácia hospitalar: permite a atualização das equipas sobre conteúdos nacionais de farmacovigilância. A fonte selecionada não detalha os conteúdos específicos desta edição.

Fontes: INFARMED, I.P.: infarmed.pt

Contexto Regulamentar Anterior ao Período de Referência: Regulamento de Execução (UE) 2025/1466. A fonte analítica descreve o Regulamento de Execução (UE) 2025/1466 da Comissão, adotado a 22 de julho de 2025, como uma alteração substantiva ao Regulamento de Execução (UE) n.º 520/2012. Segundo a fonte, algumas alterações, incluindo mudanças ao conceito de monitorização de sinais e ao uso de dados do EudraVigilance, entraram em vigor em 12 de agosto de 2025, aplicando-se as restantes a partir de 12 de fevereiro de 2026. A fonte refere ainda que, a partir de fevereiro de 2026, os titulares de AIM passam a documentar no Pharmacovigilance System Master File apenas desvios maiores ou críticos.

Relevância para a farmácia hospitalar: a fonte descreve alterações dirigidas sobretudo às responsabilidades dos titulares de AIM e não especifica um impacto operativo direto nos serviços farmacêuticos hospitalares. Trata-se de uma fonte anterior ao período de referência e de natureza analítica, não regulamentar primária.

Fontes: Arthur Cox: arthurcox.com

Outras Novidades Relevantes

Contexto de Inovação Anterior ao Período de Referência: Automatização e Farmacovigilância Autónoma na Gestão de Sinais. Artigo de análise setorial publicado em 16 de junho de 2026 defende que o processamento autónomo de ICSR, de ponta a ponta, poderia tornar obsoletos alguns dos atuais prazos de notificação, incluindo o prazo de sete dias para SUSAR, deslocando a deteção de sinais de uma atividade periódica e retrospectiva para um processo contínuo e quase em tempo real. O artigo aponta iniciativas da EMA e da FDA como indicadoras de uma orientação para monitorização proativa e propõe um horizonte de cinco anos para implementação em escala.

Relevância para a farmácia hospitalar: é conteúdo de contexto e formação, sem ação local imediata. Não constitui, por si só, alteração regulamentar nem evidência de implementação desta abordagem nos hospitais.

Fontes: Pharmaceutical Technology: pharmtech.com

Papel do MedDRA na Codificação e Monitorização Global de Segurança. Artigo de perspetiva publicado em 24 de novembro de 2025 descreve a adaptação do MedDRA MSSO e do ICH

durante a pandemia de COVID-19, incluindo o desenvolvimento e a atualização de termos e ferramentas MedDRA específicos. O artigo salienta a utilidade destes recursos para a notificação, codificação e análise de eventos adversos após imunização (AEFI).

Relevância para a farmácia hospitalar: pode apoiar a formação sobre codificação e harmonização terminológica na notificação de RAM. A fonte é anterior ao período de referência.

Fontes: *Frontiers in Drug Safety and Regulation*: frontiersin.org

ARTIGO CIENTÍFICO EM DESTAQUE — DEEP DIVE

Título traduzido: Desenvolvimento e avaliação-piloto de um modelo de vigilância baseado em alertas eletrônicos para uso indevido de sedativos-hipnóticos num hospital terciário [P2]

PubMed: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42680786

Objetivo do estudo: Desenvolver e testar em piloto um modelo de vigilância ativa, integrado no Hospital Information System (HIS) e baseado em alertas eletrônicos, para identificar proativamente padrões de prescrição de risco elevado e suspeita de dependência de sedativos-hipnóticos (SHD), superando limitações da notificação passiva.

Tipo de estudo: Estudo em duas fases num hospital terciário — análise retrospectiva seguida de avaliação-piloto prospetiva de 10 dias.

População / base de dados: 16 609 prescrições de ambulatório na fase retrospectiva, correspondentes a 8 710 doentes; na fase prospetiva, foram gerados 200 alertas automáticos. Foram entrevistados telefonicamente 63 doentes de alto risco, selecionados entre os sinalizados com pelo menos um ano de utilização de SHD, através de entrevista estruturada baseada em critérios diagnósticos ICD-10.

Principais resultados: 30,03% dos doentes (2 616/8 710) receberam pelo menos uma prescrição off-label. Foram identificados 1 567 clusters em que múltiplos identificadores de doente partilhavam o mesmo endereço residencial, interpretados como um sinal potencial e gerador de hipóteses de desvio de medicamento. Dos 63 doentes de alto risco entrevistados, 17 cumpriram os critérios de rastreio para suspeita de dependência de SHD, correspondendo a um valor preditivo positivo de 26,98% nesta coorte selecionada. No mesmo período, o sistema de notificação passiva não registou nenhum caso. Em análise univariada exploratória, o uso de benzodiazepinas (OR 33,07; IC 95% 3,95–276,81; $p < 0,001$), a idade avançada e a duração prolongada da terapêutica associaram-se à suspeita de uso indevido.

Limitações: Piloto prospetivo muito curto, de 10 dias, realizado num único centro; dicionário de triggers baseado no Global Trigger Tool sem validação externa; VPP calculado apenas numa coorte selecionada de entrevistados; análise dos fatores associados apenas univariada e exploratória; e o sinal baseado em endereços partilhados é potencial e gerador de hipóteses.

Interpretação: Os resultados devem ser considerados exploratórios, atendendo ao desenho unicêntrico, à curta duração do piloto e à ausência de validação externa. A fonte descreve o modelo como uma abordagem potencialmente escalável para priorizar doentes de alto risco.

Porque é relevante para farmacêuticos hospitalares: Sugere, neste piloto, que a vigilância ativa baseada em alertas eletrônicos pode identificar casos de suspeita de dependência que não foram captados pela notificação passiva durante o mesmo período e pode apoiar a triagem por farmacêuticos clínicos.

Possíveis implicações: O estudo apoia a exploração de regras de deteção automática no sistema de prescrição eletrónica, incluindo duração prolongada, prescrição off-label, associações de benzodiazepinas e idade avançada, com posterior revisão clínica. Reforça a complementaridade entre vigilância ativa institucional e notificação espontânea de RAM e sugere investigação local sobre o valor preditivo dos triggers em contexto português.

CHECKLIST PRÁTICA PARA OS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

- ☐ Identificar o lote L25428A de Salofalk 3000 mg granulado, embalagem de 60 saquetas e registo n.º 5398433, nos stocks sob responsabilidade dos Serviços Farmacêuticos; impedir a sua venda, dispensa e administração; proceder à devolução das unidades conforme as instruções aplicáveis; e informar as equipas clínicas e os doentes em ambulatório de que não devem suspender o tratamento sem avaliação médica — Farmácia, Gastroenterologia, Direção Clínica — [N14]
- ☐ Disponibilizar internamente a nova edição do Boletim de Farmacovigilância do INFARMED, Volume 30, n.º 5 e 6, de maio/junho de 2026, e consultar os respetivos conteúdos — Farmacovigilância local, Formação, Comissão de Farmácia e Terapêutica — [N8]
- ☐ Monitorizar sintomas de refluxo durante a terapêutica com GLP-1 RAs, sobretudo em doentes com idade igual ou superior a 65 anos [P1]; em neonatos tratados com aciclovir, reforçar a vigilância clínica do local de perfusão e de eventos cutâneos, hepatobiliares, renais, gastrointestinais ou imunes, com atenção específica a doença de Kawasaki, hemorragia retal e colite necrosante, identificadas como não descritas na informação do medicamento [P10]

FONTES UTILIZADAS

Código	Título original	Organização / publicação	URL
N14	Recolha de lote de Salofalk: Infarmed trava distribuição mas apela à continuidade dos tratamentos	Diário de Notícias (DN)	dn.pt
P1	Multi-Database Pharmacovigilance Analysis of Gastroesophageal Reflux Disease Associated with GLP-1 Receptor Agonists: A Cross-National Signal Validation Study	PubMed	pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42682267
P10	Safety analysis of acyclovir use in neonates based on the FDA Adverse Event Reporting System: A retrospective observational pharmacovigilance study	PubMed	pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42675701
N8	Nova edição do Boletim de Farmacovigilância	INFARMED, I.P.	infarmed.pt
N15	Update to the Pharmacovigilance Legislative Framework – what do Marketing Authorisation Holders need to know?	Arthur Cox	arthurcox.com
N22	Reimagining Signal Management: How Autonomous Pharmacovigilance Could Render Reporting Timelines a Thing of the Past	Pharmaceutical Technology	pharmtech.com
N18	The role of MedDRA in global pharmacovigilance and public health during COVID-19: pandemic preparedness and response	Frontiers in Drug Safety and Regulation	frontiersin.org
P2	Development and pilot evaluation of an electronic trigger-based surveillance model for sedative-hypnotic drug misuse in a tertiary hospital	PubMed	pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42680786

8 fontes citadas neste relatório.

NOTA METODOLÓGICA

Este relatório resulta da análise integrada de fontes regulamentares nacionais (INFARMED) e de publicações científicas indexadas, bem como notícias e artigos de imprensa especializada, referentes aos últimos 30 dias.

O período de referência corresponde aos últimos 30 dias e os destinatários são os farmacêuticos hospitalares em Portugal.

Relatório produzido pela PDH para a produção de informação relevante em farmacovigilância.